

■ 周術期リハ／フレイル

高齢者の術前プレハビリ、大規模RCTで効果示せず

独19施設1,382人、12か月後の要介護度に有意差なし

ドイツの19施設で行われた多施設RCT「PRAEP-GO」。70歳以上でフレイル・プレフレイルがあり待機手術(51%が整形外科手術)を予定する患者を対象に、共同意思決定で目標を決めた3週間・30回の個別化プレハビリ(運動・栄養・認知/心理支援等)と通常ケアを比較した。

1,382人が無作為割付され、12か月後の要介護度

(0～5の順序尺度)を評価できた1,199人(平均78歳)で解析。群間差は -0.1(95%CI -0.25 ～ 0.07、p=0.33)と有意差なし。セッション遵守は良好(30回中中央値29.5回)で、実施不足が原因ではなかった。

著者らは「短期の監督下プレハビリを、この対象に一律の術前パスとして導入すべきではない」と結論。より長期で行動

変容に踏み込んだプログラムや、恩恵を受けやすいサブグループの特定が今後の課題とした。



「やればやるほど良い」という前提を、大規模RCTがいったん立ち止まらせた

出典 **Lancet Healthy Longev (PubMed)**

数字で見る

1,382人

無作為割付（独19施設）

-0.1

要介護度の群間差（95%CI -0.25～0.07）

29.5 /30回

セッション遵守（中央値）

■ 脳卒中／転倒予防

脳卒中後の転倒予防、運動療法で発生件数39%減

香港理工大学らの国際チームがPRISMA準拠で系統的レビュー・メタ解析を実施。転倒回数は運動療法群で39%減少(発生率比 IRR0.61、95%CI0.47-0.78)。一方、外傷を伴う転倒(I RR0.63)や転倒した人数自体(I RR0.88)は信頼区間が1をまたぎ、効果は不明瞭だった。

サブグループ解析では、バランス訓練単独や運動+認知課題(二重課題



・心身統合運動等)を組み合わせたプログラムが、歩行訓練や筋力訓練単独より効果的。慢性期で軽～中等度の障害がある人ほど恩恵を受けやすい傾向も示された。

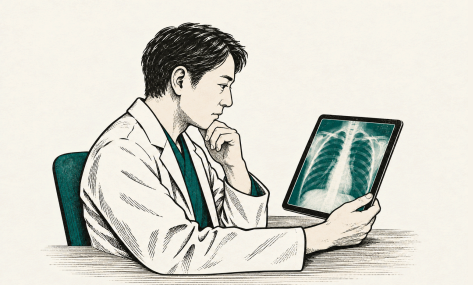
出典 **Phys Ther (PubMed)**

■ 医療AI／実装研究

胸部X線AIトリアージ、医師の信頼を左右する要因は

シンガポールの公立ポリクリニックで、胸部X線AIトリアージ「Lunit INSIGHT CXR」の運用実態を医師20人への半構造化面接・フォーカスグループで調査。継続利用を左右したのは、AI精度への信頼と自身の読影への自信だった。

組織の承認・段階的導入・同僚の良い経験・放射線科医による正式読影という安全網が信頼を後押しした一方、「AIが異常



を過剰に拾う」「臨床文脈とのやり取りができない」「誤り時の責任の所在が不明瞭」という懸念がAI単独への依存を抑えていた。

出典 **J Med Internet Res**

短 信

〈上肢リハ〉脳卒中の腕リハ、心拍70%超えが鍵

米国121人の後ろ向き研究。70%HRmax到達と体重支持の使用がADL改善と関連(各p=.04/.02) 出典 **Am J Occup Ther**

〈認知症〉高度なケア要る高齢者、認知症リスク高く

台湾11,297人の全国調査。経管栄養・透析等を要する群は認知症18.0%(通常8.0%、p<0.0001) 出典 **J Prev Alzheimers Dis**

〈感染症〉季節性インフル、重症化の危険因子を統合

63件・215万人のメタ解析。二次細菌感染OR4.13、65歳以上OR2.47などWHO指針改定に活用へ 出典 **Lancet Respir Med**

〈循環器〉アジア人HFpEF、新スコアで予後予測改善

台湾448人の前向きレジストリ。新スコアはC統計量0.65で既存スコア(0.53/0.57)を上回る 出典 **J Am Heart Assoc**

〈フレイル〉運動+栄養介入、IGF-1改善効果はなお不確実

19RCTのネットワークメタ解析。筋トレ+栄養が最上位も対照群比で有意差なし、確実性は低い 出典 **J Sports Sci**

〈整形外科〉大腿骨骨折予防、運動と栄養が土台に

スペインからの総説。骨格筋量の維持と社会経済的要因が予防の鍵、薬剤の効果は限定的とも指摘 出典 **Rev Esp Cir Ortop Traumatol**

〈医療AI〉敗血症のAI予測、精度は高いが検証途上

34件統合、判別能AUROC0.913も予測区間0.660-0.983と幅広い。前向き検証はまだ少ない 出典 **J Med Internet Res**

〈制度〉OTC類似薬、患者特別負担が2027年3月開始

薬剤費の4分の1を追加負担。がん患者・指定難病・妊婦等は対象外。詳細は9月中旬に通知 出典 **厚生労働省**